DỊ TẬT HẬU MÔN - TRỰC TRÀNG

Vũ Hồng Tuân, Nguyễn Việt Hoa, Hoàng Văn Hùng

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Trình bày được phân loại quốc tế về bệnh dị tật hậu môn trực tràng.

2. Phân biệt được các triệu chứng lâm sàng trong chẩn đoán thể bệnh dị tật hậu môn trực tràng.

3. Trình bày được các phương pháp cận lâm sàng chẩn đoán dị tật hậu môn trực tràng.

4. Tổng hợp được nguyên tắc điều trị bệnh dị tật hậu môn trực tràng.

NỘI DUNG

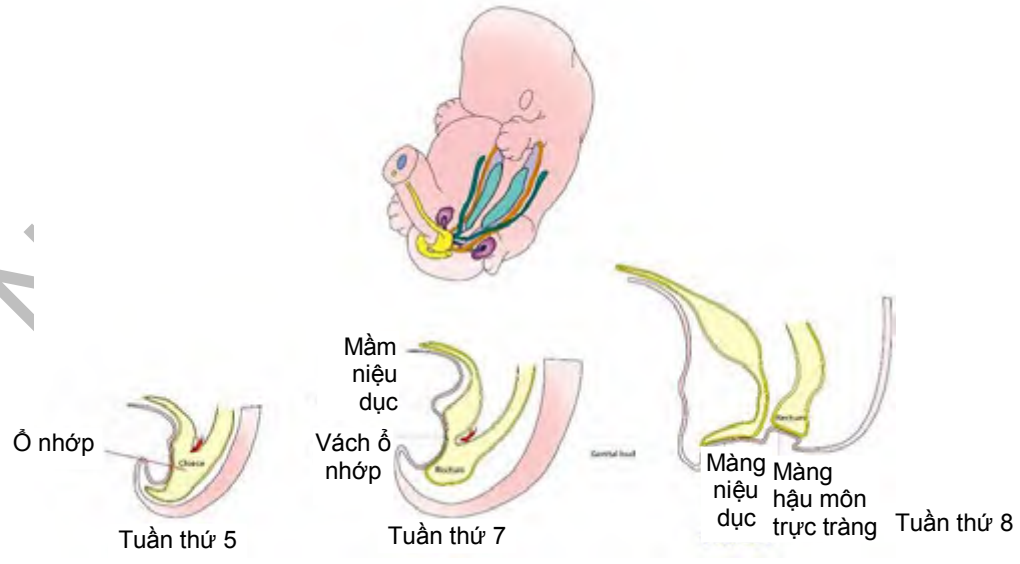
1. ĐẠI CƯƠNG

Dị tật hậu môn trực tràng (DTHMTT) là dị tật không có lỗ hậu môn, có hoặc không có đường rò từ ống hậu môn - trực tràng ra tầng sinh môn hoặc đường tiết niệu, cơ quan sinh dục.

Là dị tật bẩm sinh hay gặp ở đường tiêu hóa, cần được phát hiện và điều trị sớm ngay từ khi trẻ mới sinh. Tỷ lệ tử vong ngày càng giảm.

1.1. Phôi thai học

- Thời kỳ bào thai (tuần thứ 4 → tuần thứ 8): Ruột sau (phát triển thành trực tràng) và niệu nang (phát triển thành bàng quang) thông nhau trong một khoang gọi là ổ nhớp, phía dưới được bịt kín bằng màng ổ nhớp.



Hình 1. Phôi thai học dị tật hậu môn trực tràng

LƯU HÀNH NỘI BỘ

- Màng ổ nhớp tiêu đi → đường tiêu hóa - sinh dục - tiết niệu thông với bên ngoài.

- Vách tiết niệu - trực tràng phát triển xuống dưới → phân chia trực tràng ra khỏi đường tiết niệu - sinh dục.

- Quá trình phân chia này, nếu bất thường ở một giai đoạn nào đó → Gây ra bệnh lý dị tật hậu môn trực tràng.

1.2. Diễn biến và biến chứng

Nếu không điều trị kịp thời:

- Nôn → trào ngược đường hô hấp:

+ Chết đột ngột do sặc.

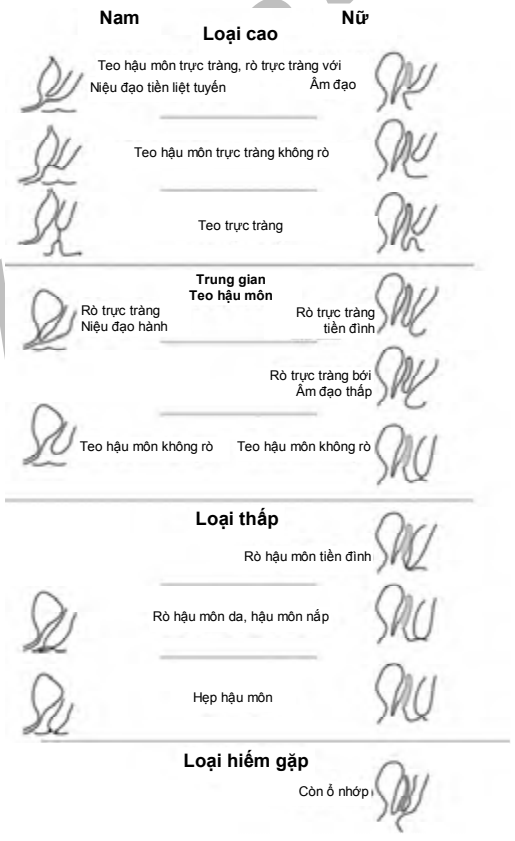
+ Nhiễm trùng đường hô hấp.

- Tắc ruột → vỡ ruột.

- Giãn đại tràng thứ phát (hẹp hậu môn).

1.3. Phân loại quốc tế

Tại Hội nghị phẫu thuật Nhi thế giới tại Wingspred (Mỹ), 1986 đưa ra phân loại mà ngày nay vẫn hay dùng.



Hình 2. Phân loại dị tật hậu môn trực tràng Wingspred (1986)

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Lâm sàng

- Đa số biểu hiện hội chứng tắc ruột sơ sinh: không ỉa phân su, nôn, bụng trướng.

- Một số ít vẫn ỉa phân su (qua lỗ rò, hẹp hậu môn).

- Cần khám: Vết tích hậu môn, lỗ rò phân, phân ra qua các đường tự nhiên (niệu đạo, âm đạo).

- Vết tích hậu môn:

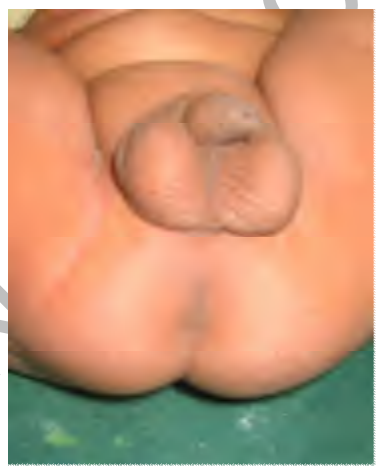
+ Lúm da sẫm màu.

+ Vị trí: Bình thường hoặc bất thường.

+ Khi trẻ khóc: Phồng lên hoặc không.

+ Ấn ngón tay: Mềm hoặc chắc.

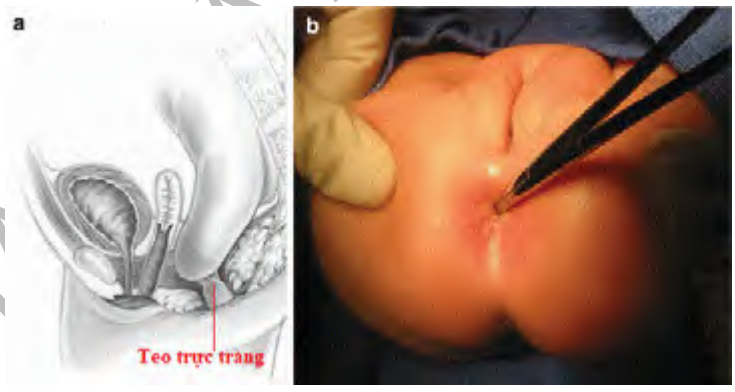
+ Cơ thắt hậu môn: Kích thích gây đau chỗ vết tích hậu môn, nếu có cơ thắt → da co rúm lại.



Hình 3. Vết tích hậu môn

2.1.1. Có hậu môn bình thường

Hậu môn bình thường về hình dạng và kích thước nhưng có biểu hiện lâm sàng của hội chứng tắc ruột sơ sinh thấp: thăm hậu môn hay đặt thông trực tràng có cảm giác dừng lại của một túi cùng → teo trực tràng.



Hình 4. Teo trực tràng

2.1.2. Không có hậu môn hay hậu môn bất thường

a. Ở nam

* Không có lỗ rò:

- Không có phân su trong nước tiểu: DTHMTT không dò (cao), dị tật không hậu môn (trung gian), hậu môn nắp (thấp). Việc chẩn đoán phân biệt thể loại sẽ được thực hiện bằng X quang

- Có phân su trong nước tiểu: DTHMTT có dò trực tràng niệu đạo tiền liệt tuyến (cao) hay dò trực tràng - niệu đạo hành (trung gian) → Chẩn đoán phân biệt ở đây không cần đặt ra ở lứa tuổi sơ sinh vì phương pháp thường là làm hậu môn nhân tạo cho thể này.

* Lỗ rò: Ở tầng sinh môn trước: rò hậu môn da (thể thấp).



Không hậu môn, không đường rò, không tiểu phân su



Dị tật hậu môn có rò tầng sinh môn



Tiểu ra phân su

Hình 5. Một số hình ảnh dị tật hậu môn trực tràng ở trẻ nam

b. Ở nữ

* *Không có phân su thoát ra:* DTHMTT không dò (cao hay trung gian) hay hậu môn nắp (thấp).

* *Bệnh nhân có lỗ âm đạo và niệu đạo riêng:* Phân su đi ra từ âm đạo (phía trong màng trinh): bất sản hậu môn trực tràng có rò trực tràng - âm đạo (cao) hay rò trực tràng - âm đạo (trung gian) → Chẩn đoán phân biệt ở đây không cần đặt ra ở lứa tuổi sơ sinh vì phương pháp thường là làm hậu môn nhân tạo cho thể này.

* *Chỉ có 1 lỗ ở tầng sinh môn*: Còn ổ nhớp.

* *Lỗ rò phân từ vị trí tiền đình:* Rò trực tràng - tiền đình (trung gian) hay rò hậu môn - tiền đình (thấp). Chẩn đoán phân biệt sẽ được thực hiện bằng cách đặt thông thăm dò: thông đi lên, song song với trục âm đạo: rò trực tràng tiền đình (trung gian); thông có khuynh hướng đi ngang, song song với mặt da: rò hậu môn - tiền đình (thấp).

* *Lỗ rò ở tầng sinh môn dưới âm hộ:* Rò hậu môn - da (thể thấp).

Thăm khám tìm các dị tật phối hợp: Dị dạng ở xương cùng - cụt, nhiễm sắc thể, hệ tiết niệu - sinh dục... Những bệnh nhân bị bất sản xương cùng - cụt thường bị rối loạn chức năng đại - tiểu tiện.

NHÀ XUẤT BẢN Y



Lỗ rò tầng sinh môn



Còn ổ nhớp (Cloaca)



Hậu môn tiền đình

Hình 6. Một số hình ảnh dị tật hậu môn trực tràng ở trẻ nữ

2.2. Cận lâm sàng

2.2.1. Chụp X quang đầu dốc

- Cách chụp phim X quang dị tật hậu môn trực tràng (Wangensteen và Rice, 1930)

+ Thời điểm chụp: 18 - 24 giờ sau sinh.

+ Đặt sonde dạ dày phòng nôn - trào ngược.

+ Tư thế bệnh nhân: Nằm sấp, đầu thấp, mông cao, độn vùng mu.

+ Đánh dấu chì vào vết tích hậu môn.

+ Tấm phim đặt ở một bên và bóng chụp ở bên đối diện.

+ Đặt tư thế bệnh nhân rồi chụp sau 5 phút.





Hình 7. Tư thế chụp X quang dị tật hậu môn trực tràng

- Mục đích: Tìm túi cùng trực tràng (TCTT).

So sánh TCTT với:

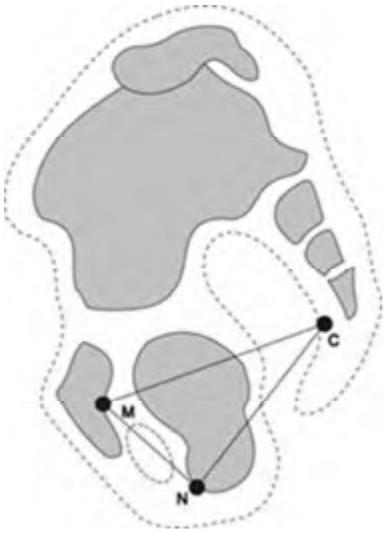
* Mốc xương: Tam giác mu - ngồi - cụt (MNC):

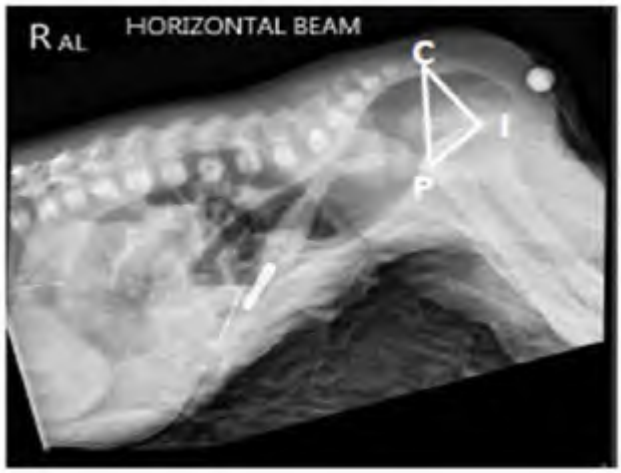
+ TCTT trên đường mu - cụt: Dị tật cao.

SÁCH XUẤT BẢN Y HỌC

+ TCTT trong tam giác MNC: Dị tật trung gian.

+ TCTT dưới đường ngồi - cụt: Dị tật thấp.





Trường hợp này thể thấp

Hình 8. So sánh với mốc xương

* Mốc đánh dấu (vết tích hậu môn): Đo khoảng cách từ túi cùng trực tràng đến vết tích hậu môn.

+ Nếu dài trên 2cm: Dị tật cao.

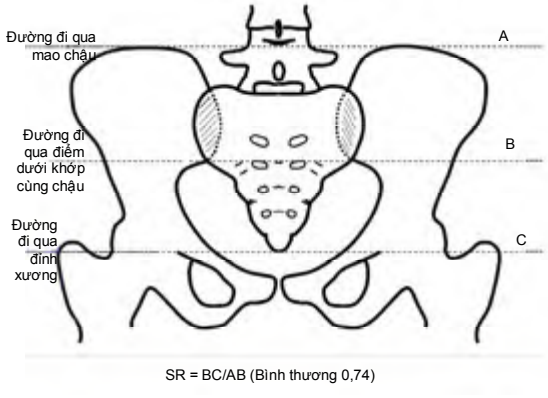
+ Nếu dài bằng 2 cm: Dị tật trung gian.

+ Nếu dài dưới 2 cm: Dị tật thấp.

2.2.2. Chụp khung chậu: Cần đánh giá các khiếm khuyết xương cùng trên phim X quang để tiên lượng về sự đại tiện tự chủ sau này.

Đo tỉ số xương cùng (Sacral ration - SR): Có giá trị tiên lượng đại tiện tự chủ hay không.

SR < 0,4: Tiên lượng kém, đại tiện không tự chủ.





Hình 9. X quang khung chậu và chỉ số xương cùng

NHÀ XUẤT BẢN

2.2.3. X quang có chuẩn bị

Thuốc cản quang bơm vào:

- Túi cùng trực tràng (chọc kim qua vết tích hậu môn): Ít sử dụng.
- Lỗ rò.
- Hậu môn nhân tạo.



Hình 10. Bơm thuốc cản quang qua hậu môn nhân tạo

2.2.4. Siêu âm

Đo khoảng cách giữa vết tích hậu môn tới túi cùng trực tràng để xác định thể bệnh:

- Khoảng cách dài hơn 1 cm là dị tật thể trung gian hoặc cao.
- Khoảng cách ngắn hơn 1 cm là thể thấp.
- Tìm các dị tật phối hợp ở hệ tim mạch, hệ tiết niệu, tiêu hoá ...

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Xử trí ban đầu

- Thông dạ dày làm giảm bớt trướng bụng.
- Bù nước điện giải, nuôi ăn tạm thời bằng đường tĩnh mạch.
- Kháng sinh phòng ngừa nhiễm trùng.
- Vitamin K.
- Bilan thương tổn phối hợp: Khám lâm sàng, siêu âm: tim, thận, não.
- X quang thế chúc đầu được thực hiện 12 - 24 giờ sau sinh (nếu cần).

3.2. Nguyên tắc phẫu thuật

** Mục đích:* Cứu sống bệnh nhân, tạo hậu môn ở vị trí bình thường, đảm bảo chức năng đại tiện.

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

** Chỉ định:*

- Hậu môn bịt kín, không có lỗ rò → Mổ cấp cứu.
- Hậu môn bịt kín, có lỗ rò:

+ Có thể trì hoãn một thời gian.

+ Nong lỗ rò trong khi chờ mổ.

- Hẹp hậu môn hay hẹp hậu môn trực tràng:

+ Nong.

+ Không có kết quả → Mổ.

* Phương pháp mổ:

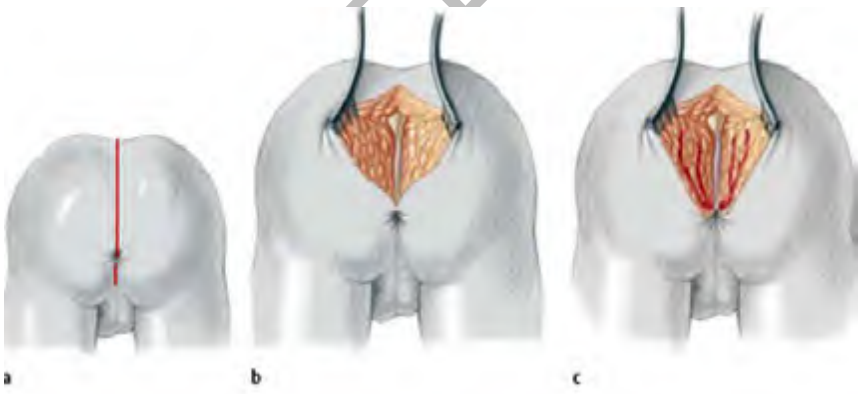
- Dị tật cao và trung gian: Mổ 3 thì:

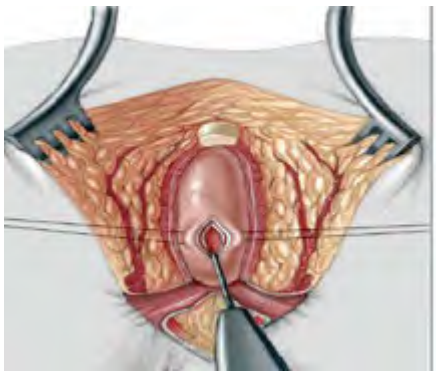
+ Làm hậu môn nhân tạo sau đẻ.

+ Hạ bóng trực tràng sau 3 - 6 tháng:

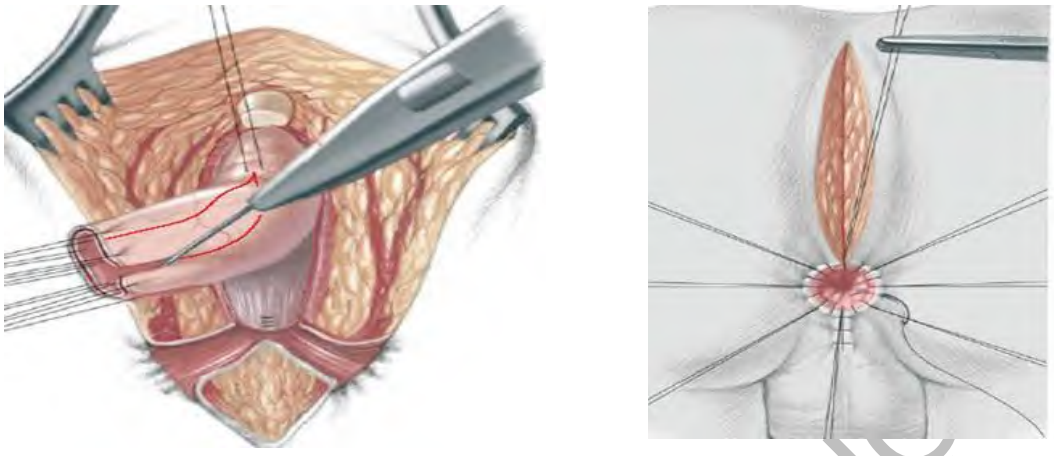
- Nội soi ổ bụng.
- Đường bụng + Tầng sinh môn.
- Đường sau trực tràng (PSARP): Phương pháp Pena.

+ Đóng hậu môn nhân tạo sau 2 - 3 tháng.





NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC



Hình 11. Hạ bóng trực tràng đường sau (PSARP)

- Dị tật thấp: Mổ một thì: tạo hình hậu môn hay hạ đại tràng đường tầng sinh môn.

- Một số tình huống đặc biệt:

+ Teo trực tràng: giải phóng hai đầu trực tràng → Nối tận - tận.

+ Hẹp hậu môn trực tràng: Nong không kết quả → Mổ cắt đoạn hẹp → Nối trực tràng + ống hậu môn.

4. NONG HẬU MÔN

Cần được thực hiện từ ngày hậu phẫu thứ 10 - 14, tiến hành trong ít nhất là 6 tháng để tránh hẹp hậu môn sau mổ.

4.1. Tần số nong

- Tháng đầu tiên: Một lần/ngày.

- Tháng thứ 2: Một lần/3 ngày.

- Tháng thứ 3: Hai lần/tuần.

- Ba tháng kế: Một lần/tuần.

4.2. Cỡ nong: Dùng bộ nong Hegar

Tuổi	Cỡ nong (Fr)
1 - 3 tháng	12 H
4 - 8 tháng	13
9 - 12 tháng	14
1 - 3 tuổi	15
4 - 12 tuổi	16
Trên 12 tuổi	17 - 18

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ môn ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội (2006), *"Bệnh học ngoại khoa - Dành cho sinh viên Y6"*, Nhà xuất bản Y học.
2. Nguyễn Thanh Liêm (2016), *Phẫu thuật tiêu hóa trẻ em,* Nhà xuất bản Y học.
3. Trần Ngọc Bích (2006), *Cấp cứu ngoại khoa, tập 1,* Nhà xuất bản Y học.
4. Bộ môn phẫu nhi Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh (2017), *"Ngoại Nhi lâm sàng",* Nhà xuất bản Y học.
5. Bệnh viện Nhi Đồng II (2013), *Phác đồ điều trị ngoại Nhi,* Nhà xuất bản Y học.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1: Bạn hãy trình bày các triệu chứng lâm sàng chẩn đoán dị tật hậu môn trực tràng?

Câu 2: Bạn hãy trình bày các biện pháp cận lâm sàng chẩn đoán dị tật hậu môn trực tràng?

Câu 3: Trình bày phân loại quốc tế dị tật hậu môn trực tràng?

Câu 4: Trình bày nguyên tắc điều trị dị tật hậu môn trực tràng?

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC